高雄榮民總醫院護理部護理指導單張

科　　別	精神部	編號：7G70002
主　　題	思覺失調症的治療方法	2015.11.27 訂定
製作單位	GW07 病房	2020.08.26 二修

一、什麼是思覺失調症

思覺失調症是一種包括思考、情感、行為等多方面障礙的精神疾病，導致其精神生活與現實世界明顯脫節，使日常生活無法自理，功能退化。

二、思覺失調症有哪些症狀？

(一)幻覺：是一種知覺障礙，有視、聽、嗅、觸等幻覺，思覺失調症以幻聽最常見。

(二)妄想：是一種錯誤且偏離事實的想法，雖然經過不斷解釋或事實證明，仍無法改變其想法（如：認為有人要害他的被害妄想、認為旁人的一言一行都與他有關的關係妄想等）。

(三)胡言亂語：言語片段或停頓、自創新字、表達前後不連貫等。

(四)混亂行為：嚴重時會出現攻擊、破壞、自殺等不適當行為。

(五)負性症狀：情感冷漠，缺乏情緒表達，人際關係退縮，多獨處。

三、思覺失調症的治療

（一）藥物治療

常用藥物如下列圖示，可以減少妄想、幻覺等精神症狀，需長期規則服藥，切勿自行停藥，避免疾病復發。若無法規則服藥，可考慮輔助使用其他長效型針劑，依醫師評估約每二到四週或三個月注射一次，藥物可在體內慢慢地釋放，維持效用，穩定病情。

Sulpiride 50mg (舒立寧)



Solian 200mg (首利安)



Quetiapine 300mg (思樂康)



Olanzapine 5mg (樂安神)



Risperdal Consta(維思通) 25mg



Invega Sustenna (善思達) 150mg



（二）職能治療

運用不同治療活動有目的改善及增加人際互動、回歸家庭及社會功能，達到復健治療效果，增進對社會環境的適應能力。

（三）團體治療

以團體治療的方式，增進與他人互動的機會，學習人際互動技巧。

（四）心理治療

以個別方式藉由會談找出情緒障礙原因，修正不切實際的想法與習慣，引導及協助適當處理。

（五）電痙治療

若藥物反應效果不佳，症狀干擾嚴重影響日常生活時，可考慮使用電痙治療。

（六）復健治療

1.日間病房：病情穩定後，白天來院參加復健活動，培養獨立生活能力、增進解決問題技能及學習人際互動技巧、養成規律作息的良好習慣。





日間病房

2.社區復健中心：提供輕度功能退化需積極復健，且具備復健動機及潛能者、能獨立接受訓練並主動服藥及規則門診治療者，進行復健治療，提供多樣化的學習活動，以恢復或維持社會功能，激發潛能，培養工作態度與能力。

參考資料：

黃宣宜(2018)．*思覺失調類群及其他精神病症之護理*．黃宣宜校閱．最新精神科護理學(十版，13-3-13-26 頁)．台北：永大。

蔡素玲、徐瑩嫩、理怡賢（2018）．*思考障礙的護理*．蕭淑貞校閱，精神科護理學(四版，262-382 頁)．新北市：新文京。

備註：每年審閱一次

所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷，若有問題，請向門診醫師或原住院病房諮詢！